



Pilotage des arrêts longue durée

Agissez sur les arrêts de travail longs, disproportionnés ou injustifiés.

Limitez la durée des arrêts et réduisez les coûts de l'absence.



Le problème n'est pas l'accident. C'est la dérive de la durée d'arrêt.

Les entreprises investissent dans la prévention des accidents du travail. Mais elles négligent ce qui se passe **après l'accident** : la durée de l'arrêt dérive, les seuils se franchissent, et les coûts explosent.

Plus de la moitié des arrêts longs présentent une durée disproportionnée par rapport aux lésions constatées. Pourtant, **personne ne les questionne**. La paie subit, la CPAM ne contrôle pas spontanément, et le coût s'impute sur votre compte employeur.

Le problème n'est pas l'accident. C'est l'absence d'action entre le 45ème jour et le moment où le seuil est franchi.



54% des arrêts longs disproportionnés

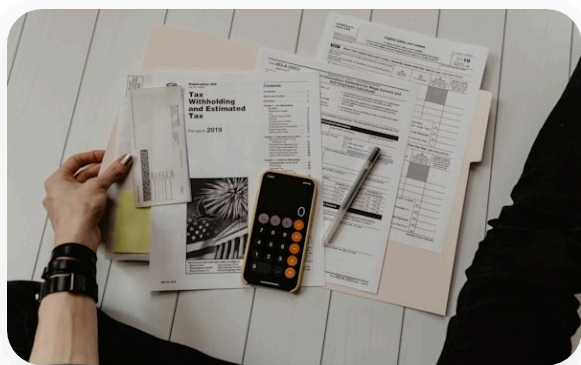
50 000 € d'écart IT4 vs IT6

Impact des arrêts longs sur les cotisations AT/MP



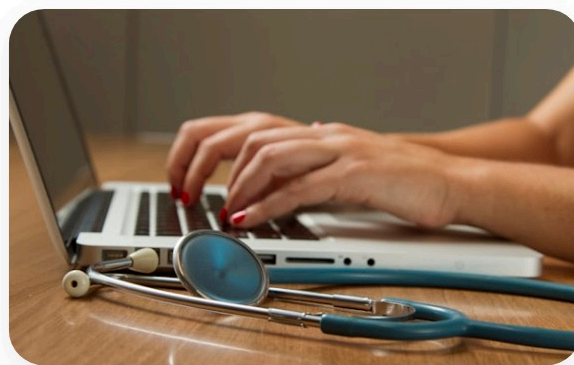
Données chiffrées issues d'un panel de clients, entre 2020 et 2025. Tout secteur d'activités confondu.

Comment les entreprises gèrent les arrêts longs aujourd'hui



Gestion interne RH

Au cas par cas. Pas de méthodologie structurée, pas de scoring, pas de suivi médico-administratif. L'équipe RH réagit quand le seuil est déjà franchi.



Contre-visite médicale

Insuffisant. Vérifie si le salarié est à son domicile. Aucune analyse médicale du dossier, aucun signalement à la CPAM, aucun suivi dans la durée.



Cabinet d'avocats

Trop tard. Intervient après consolidation, en phase judiciaire. Pas d'action en amont sur la durée de l'arrêt. Le coût est déjà imputé.



Logiciel GTA / SIRH

Partiel. Suit les dates d'absence mais ne propose ni analyse médicale, ni coordination des actions, ni signalement structuré à la CPAM.

Dans un monde idéal, voici ce que serait une maîtrise des arrêts longs



Anticipation

Voir venir les dérives avant le franchissement de seuil, pas une fois le coût imputé.



Un œil médical, pas administratif

Chaque arrêt long examiné avec une vraie compétence en accidentologie, pas par un gestionnaire RH.



Une CPAM qui agit

Un dossier suffisamment argumenté pour que le médecin-conseil révise la durée d'arrêt.



Aucun dossier oublié

Tous les arrêts longs suivis dans la durée, jusqu'à leur résolution.

Pilotage des arrêts longue durée

4500

DOSSIERS ANALYSÉS DEPUIS 2020

39%

DES DOSSIERS ACTIONNÉS RESTENT EN DESSOUS DES 150 JOURS

400+

CLIENTS

Notre mission s'appuie sur des médecins spécialisés en accidentologie qui analysent vos arrêts AT de plus de 45 jours et produisent des signalements CPAM documentés pour maîtriser la durée des arrêts et réduire vos cotisations AT/MP.

La chaîne de valeur des risques professionnels

1

Phase déclarative

- Déclaration de l'accident du travail
- Cohérence et réserves
- Échanges CPAM

Déclarer un accident du travail

2

Collecte des arrêts

- Centraliser les justificatifs
- Contrôle de conformité
- Données paie-ready

Collecter et traiter les arrêts

3

Pilotage des arrêts longs

- Détection précoce dès 45 jours
- Analyse médicale spécialisée
- Signalement CPAM
- Favoriser le retour à l'emploi

Cette offre

4

Maîtriser les cotisations AT/MP

- Contestation des imputations
- Vérification des taux et imputations
- Démarches via cabinet d'avocats indépendants
- Cotiser au juste taux

Maîtriser les cotisations AT/MP

Ayming vous accompagne sur chaque maillon. **Agir entre 45 et 150 jours, c'est éviter que le coût explose.**

Ce qu'Ayming vous apporte



Détection et analyse médicale spécialisée

Scoring mensuel des arrêts à risque.
Analyse plurifactorielle par des
médecins spécialisés en accidentologie.



Signalement structuré à la CPAM

Courrier médical argumenté au
médecin-conseil. Déclenche un contrôle
pour évaluer la justification de l'arrêt.

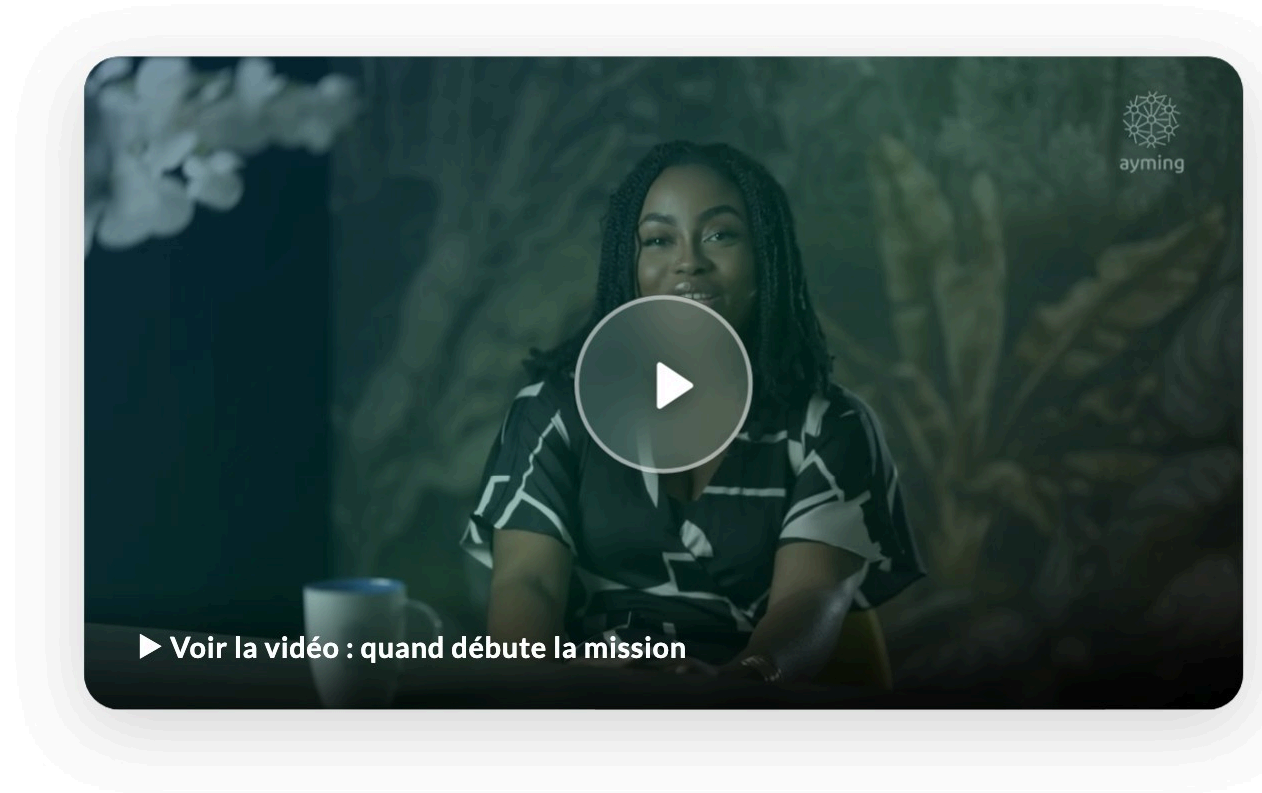


Accompagnement jusqu'à la résolution

Suivi mensuel récurrent. Au-delà de
150 jours : nouvelle analyse. Après
consolidation : démarches possibles via
cabinet d'avocats.

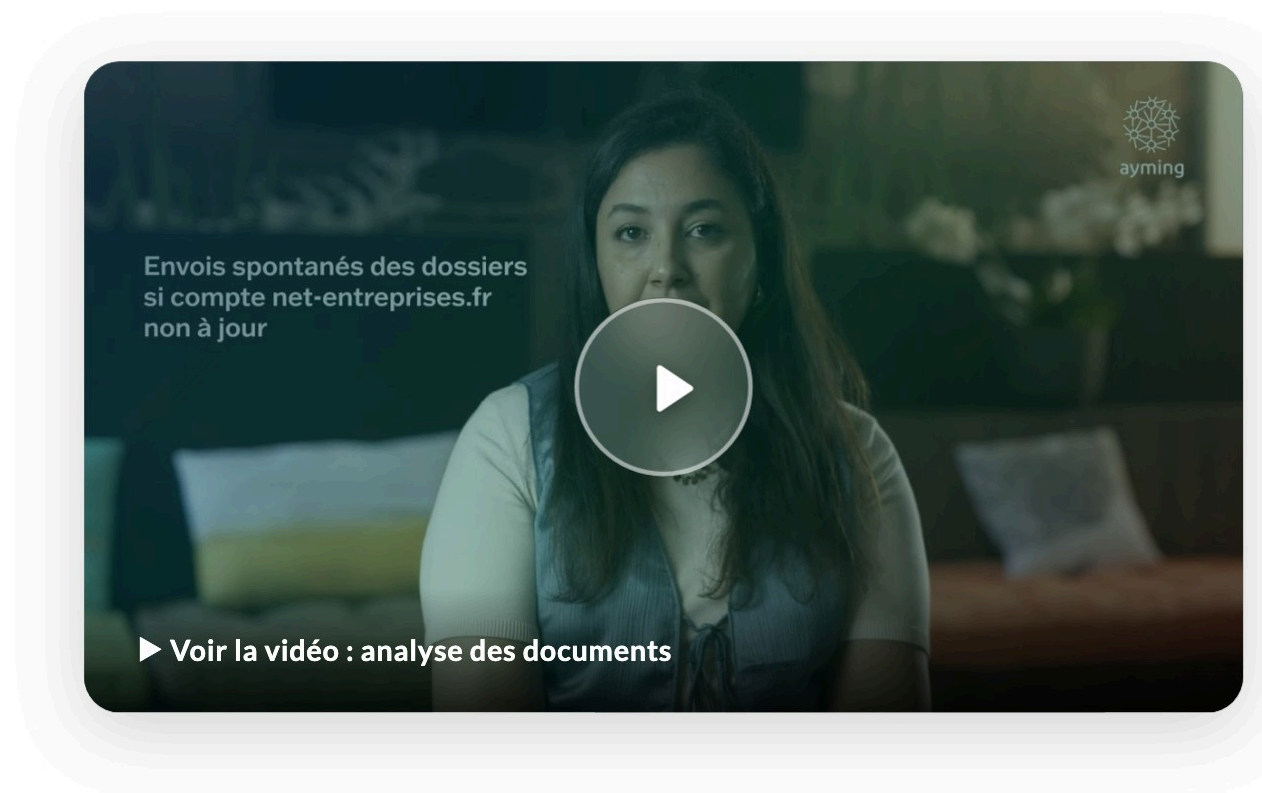
Détection et analyse médicale spécialisée

- ✓ Cartographie mensuelle avec scoring de risque pour identifier les dossiers critiques avant 45 jours
- ✓ Analyse médicale plurifactorielle : contexte accidentel, poste de travail, prescriptions, contexte géographique
- ✓ Médecins experts spécialisés en accidentologie (pas des médecins contrôleurs généralistes)
- ✓ Détection d'états antérieurs, d'incohérences de prescriptions et de durées disproportionnées



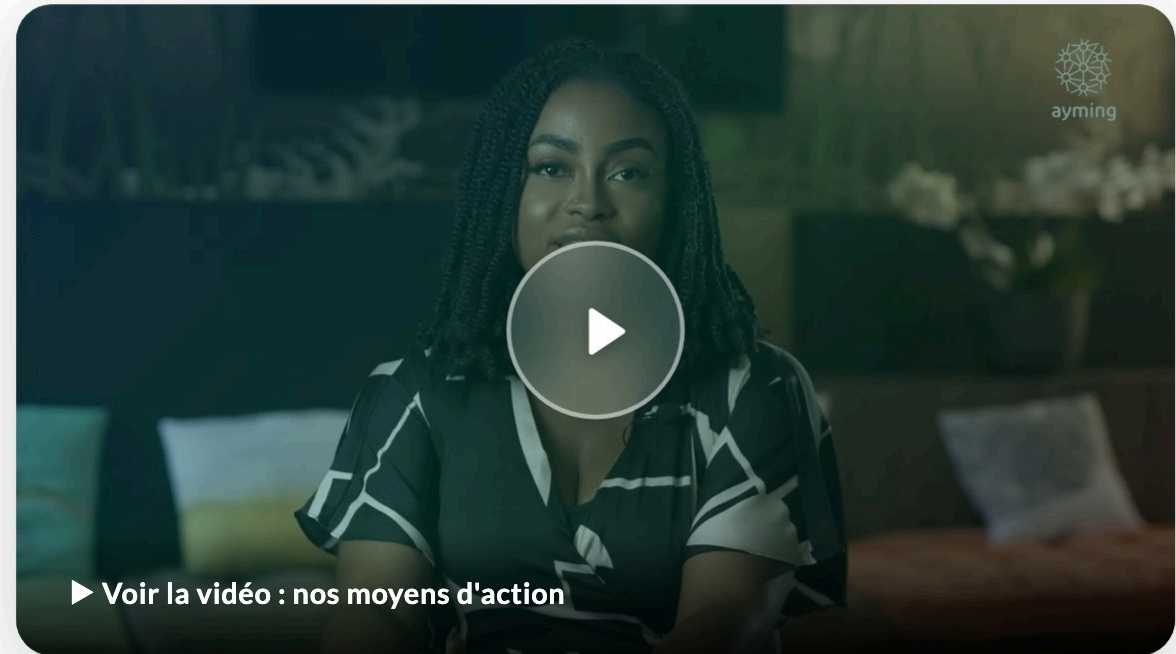
Signalement structuré à la CPAM

- ✓ Courrier de signalement médical, factuel, argumenté sur la base de l'analyse plurifactorielle
- ✓ Adressé au médecin-conseil de la CPAM
- ✓ Déclenche un contrôle : convocation du salarié, vérification du dossier, décision de consolidation
- ✓ Traçabilité complète des actions pour alimenter d'éventuelles démarches ultérieures



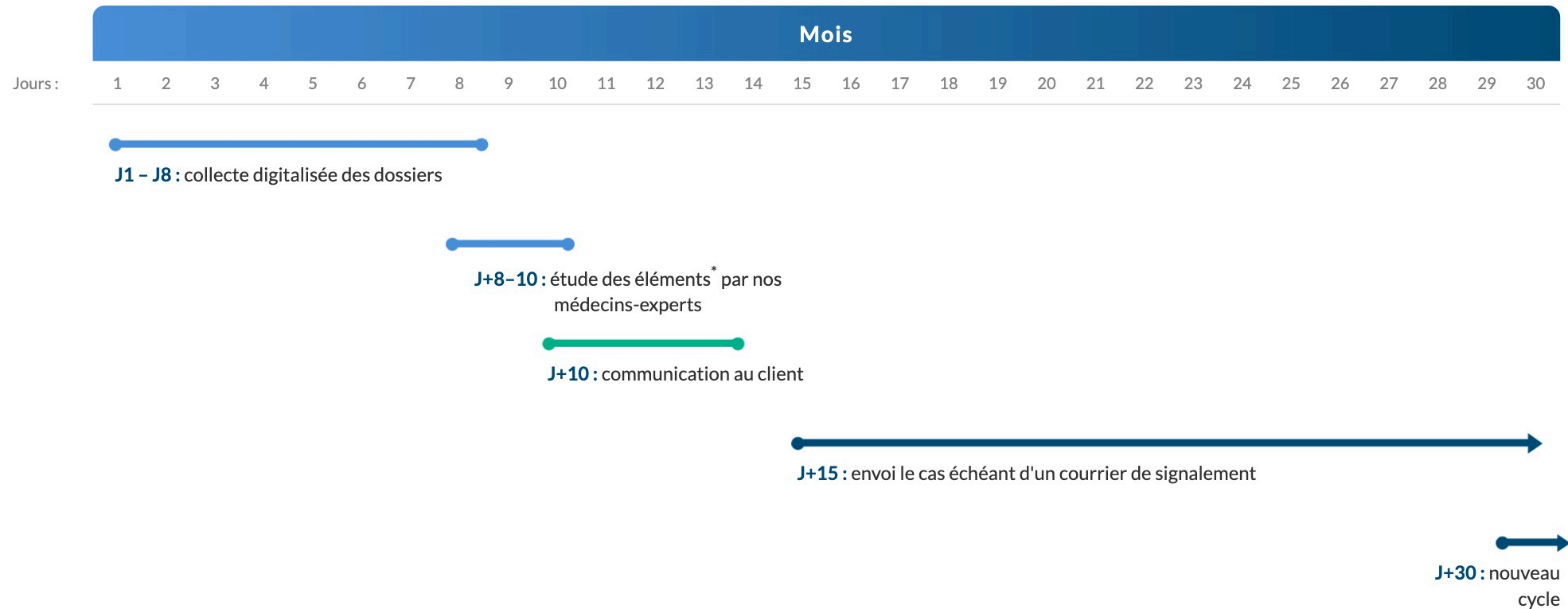
Accompagnement jusqu'à la résolution

- ✓ Cycle mensuel récurrent : détection, analyse, signalement, suivi à J+30
- ✓ Après consolidation : démarches possibles via un cabinet d'avocats indépendants, choisi d'un commun accord
- ✓ Intégré dans la chaîne de valeur AT/MP : déclaration, collecte, pilotage, cotisations



Organisation de la mission

Un cycle de travail se déroule sur **1 mois**



*L'étude porte sur les pièces administratives du dossier que l'employeur détient au regard des dispositions de l'article R441-13 du Code de la Sécurité Sociale (DAT, CMI volet employeur et éventuels échanges avec la CPAM, volet employeur des certificats médicaux de prolongation), extrait SIRH du relevé des absences du salarié, et toutes pièces fournies par la CPAM. Cet avis n'est pas un examen du patient, ni une consultation médicale, ni un diagnostic, ni un acte de traitement.

Exemple d'accompagnement

Lumbago suite à manutention

Salarié déchargeant des bacs d'assiettes. CMI : lumbago. Arrêt initial de 7 jours.

141 j

Reprise du salarié (IT5)

CE QUE L'ANALYSE A RÉVÉLÉ

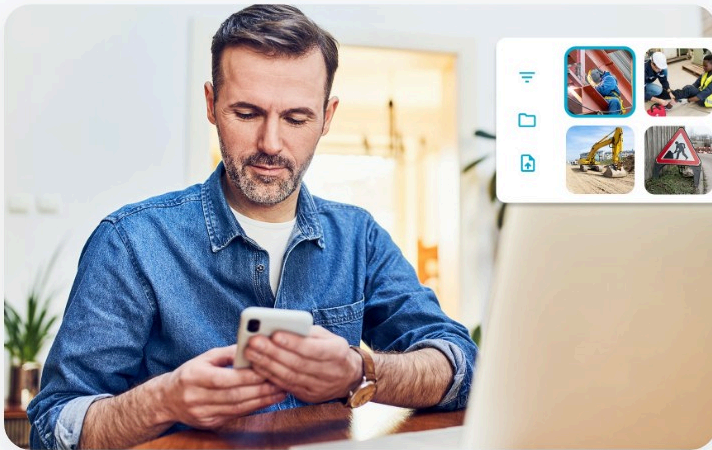
Aucun spécialiste consulté, uniquement le médecin traitant.
Prolongations de 7 ou 14 jours en série. Arrêt couvrant la période de congés payés. Durée disproportionnée pour un lumbago simple.

ACTIONS MENÉES

Deux courriers de signalement successifs à la CPAM. La CPAM a confirmé la mise en place d'une procédure de contrôle. Le salarié a repris à 141 jours.

 Reprise à IT5 (141 j) au lieu d'IT6. Économie potentielle : ~43 800 € de cotisations AT/MP.

Un accompagnement sur toute la chaîne AT/MP



EN OPTION

Déclarer un accident du travail

Sécurisez la phase déclarative de vos AT et MP.
Maîtrisez les délais, les réserves et les échanges CPAM.



EN OPTION

Collecter et traiter les arrêts de travail

Centralisez la réception des arrêts, contrôlez la conformité et livrez des données paie-ready.



EN OPTION

Maîtriser les cotisations AT/MP

Vérifiez vos taux, contestez les imputations injustifiées, maîtrisez vos coûts AT/MP.

Ils nous font confiance



STEF



STEF améliore le pilotage des arrêts de travail et des risques professionnels

 Découvrir



N
NICOLLIN



Pilotage de la longueur des arrêts de travail par Nicollin

 Découvrir



Guerbet



Guerbet repense son processus de gestion de l'absence

 Découvrir

Plus de 2 500 clients nous font confiance

AGROALIMENTAIRE



DISTRIBUTION & COMMERCE



INDUSTRIE



BTP & CONSTRUCTION



TRANSPORT & LOGISTIQUE



SANTÉ & PHARMA



SERVICES & FINANCE



TECHNOLOGIES & MÉDIAS



PUBLIC & ESS

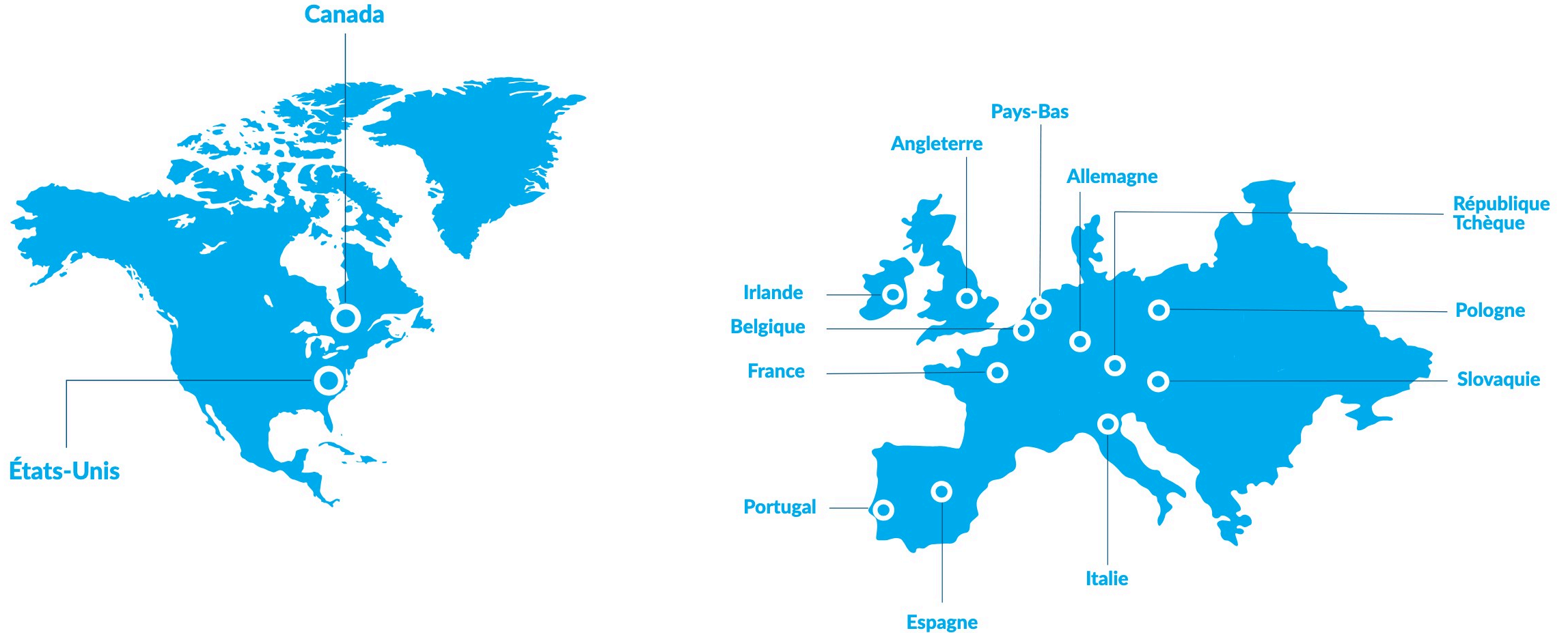


Un fort ancrage en France...

Nos équipes locales accompagnent au quotidien nos clients dans leur développement et leurs transformations **en s'appuyant sur un écosystème de professionnels en régions** : experts scientifiques, experts comptables, établissements bancaires, pôles de compétitivité, fédérations professionnelles, avec un maillage de cabinets d'avocats et de médecins indépendants.



... avec des bureaux dans 14 pays pour une proximité accrue avec nos clients et leur écosystème



Questions qu'on nous pose

Quelle différence avec une contre-visite ?

La contre-visite vérifie si le salarié est à son domicile. Les médecins sur lesquels s'appuie notre mission analysent la cohérence médico-administrative de l'ensemble du dossier. Ce n'est pas une confrontation employeur-salarié, c'est un signalement à la CPAM.

Le salarié peut-il contester ?

Le courrier de signalement est adressé à la CPAM, pas au salarié. C'est le médecin-conseil de la CPAM qui décide des suites : convocation, contrôle, consolidation. Seule la CPAM a la faculté de mettre fin à un arrêt.

Quel ROI attendre ?

Réduire un dossier d'IT6 à IT4, c'est ~50 000 € d'économie de cotisations. 39% des dossiers traités restent sous 150 jours. Le retour est mesurable dès les premiers cycles.

Que se passe-t-il au-delà de 150 jours ?

Les médecins procèdent à une nouvelle analyse avec éléments complémentaires. Après consolidation, des démarches peuvent être engagées par un cabinet d'avocats indépendants, choisi d'un commun accord.

Prochaine étape



Cadrage

30 min

Un échange pour qualifier votre périmètre, vos volumes d'AT et désigner l'interlocuteur côté Ayming.
Sans engagement.



Diagnostic et lancement

Premier mois

Diagnostic chiffré sur un échantillon de vos dossiers, puis premier flux d'AT pris en charge par nos médecins.



Premiers résultats

Dès les premiers cycles

Premiers signalements envoyés au médecin-conseil, premières révisions de durée actées par la CPAM.

Ce dont nous avons besoin

Pour démarrer l'accompagnement

- ✓ Liste des AT en cours avec arrêts de 45 jours et plus
- ✓ DAT et CMI (volet employeur) pour chaque dossier
- ✓ Extrait SIRH du relevé des absences du salarié
- ✓ Interlocuteur RH ou prévention pour le pilotage

Prochaine étape : un échange de 30 minutes pour cadrer le diagnostic de vos arrêts longue durée.

Nos partenaires

Tous

Privé

Public

ESS

DROM

Transverse

25 PARTENAIRES

